Esclerosis sistémica: ¿qué fármacos y terapias celulares vienen, y qué tan cerca están de la consulta?

Naveed E, Lescoat A, Matucci-Cerinic M, et al. Emerging drugs in phase 2/3 and selected phase 1/2 cellular-therapy trials: a glimpse into the future of systemic sclerosis treatment. *Ann Rheum Dis.* 2026. doi:10.1016/j.ard.2026.09.015 (acceso abierto)
Versión 1.0 · Revisado el 25 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Todavía no
Todo lo revisado está en ensayo; no hay terapia aprobada para la enfermedad en su conjunto.

¿QUÉ TAN SÓLIDA ES LA EVIDENCIA?
Revisión narrativa de expertos
Inventario de ensayos registrados, no de resultados; autores con muchos vínculos con la industria.

LO MÁS ÚTIL PARA LA CONSULTA
Un mapa de lo que viene
28 estudios ordenados por mecanismo, y por qué algunos ya fallaron.

En 30 segundos. Un grupo internacional de expertos en esclerosis sistémica revisó ClinicalTrials.gov (27 de marzo de 2026) y encontró 28 estudios fase 2–3 (y fase 1/2 de terapia celular) activos o recién terminados. El foco se movió de la vasculopatía a la inmunidad: depleción profunda de linfocitos B con CAR-T, CAR-NK y anticuerpos (belimumab, ianalumab, telitacicept), bloqueo de FcRn, interferón tipo I (anifrolumab, en fase 3), coestimulación (OX40L, TL1A), JAK1, y antifibróticos nuevos (nerandomilast, anti-OSMRβ, anti-IL-31R, anti-efrina-B2). Dos ya fueron negativos en su fase 2: tulisokibart y avenciguat. Hoy el estándar sigue siendo el micofenolato y los tratamientos por órgano.

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Cómo leer una revisión de "lo que viene": la diferencia entre revisión narrativa y sistemática, por qué un ensayo registrado no es un ensayo positivo, qué vale un comunicado de prensa, el salto del ratón al paciente, los desenlaces sustitutos (Rodnan, CVF) frente a los multidominio, y cómo pesar los conflictos de interés de los autores.

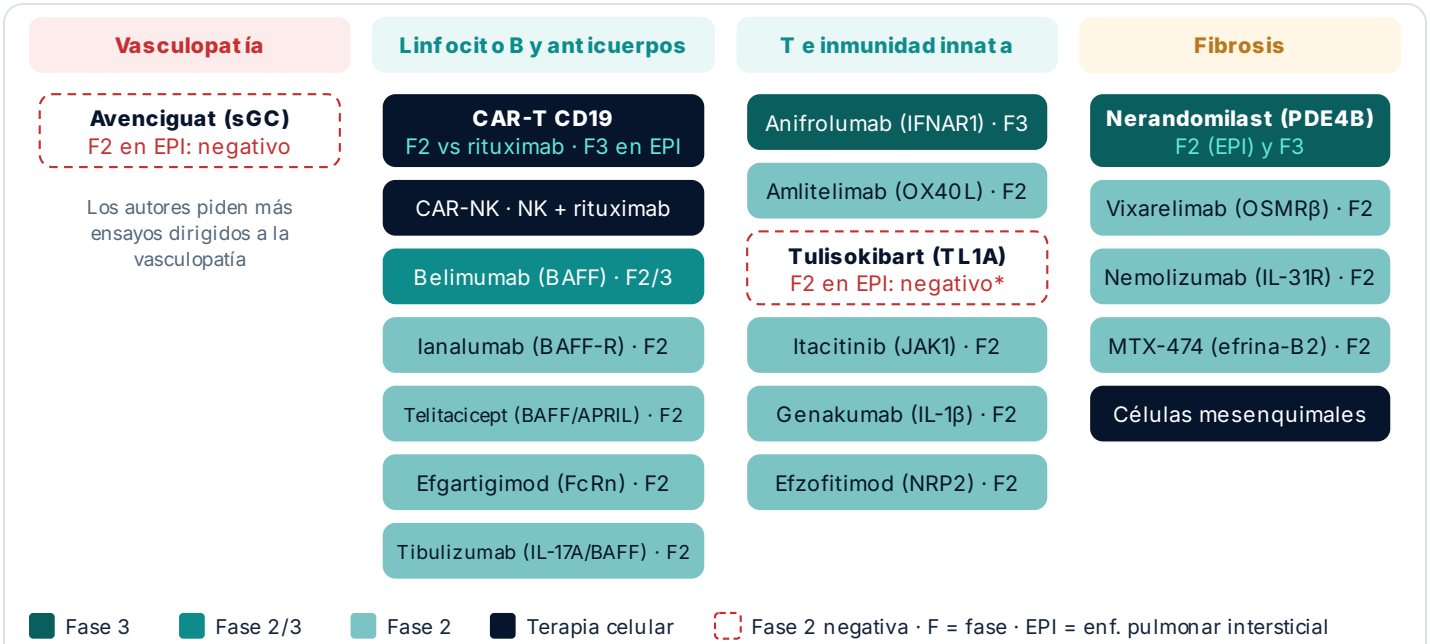
1 Qué tipo de artículo es y cuánto pesa su evidencia

TIPO	**Revisión narrativa** con búsqueda estructurada solo en un registro de ensayos. No evalúa calidad de estudios ni combina resultados.
BÚSQUEDA	ClinicalTrials.gov, "scleroderma" y "systemic sclerosis", 27-mar-2026; fase 2 y 3 (y 1/2 de terapia celular) terminados recientemente, reclutando o por reclutar. 52 registros; se excluyeron 24 (pediátricos, tópicos o intralesionales, prevención, solo eventos adversos, intervención poco clara y 14 "fase 2" que los autores juzgaron de tipo fase 1). **Incluidos: 28.**
AUTORES	Grupo internacional de expertos en esclerosis sistémica (Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá). Sin financiamiento. Declaran numerosas relaciones de consultoría o subvenciones con farmacéuticas, incluidas varias que desarrollan los fármacos revisados.
FECHAS	Recibido 4-jun-2026; aceptado 26-sep-2026; con revisión por pares externa.

2 El punto de partida: lo que ya se usa

- **Enfermedad pulmonar intersticial:** micofenolato como inmunosupresor inicial; ciclofosfamida, tocilizumab, nintedanib y rituximab como adición en escenarios específicos o en progresión.
- **Piel:** micofenolato y metotrexato (EULAR y la Sociedad Británica de Reumatología); EULAR incluye además tocilizumab y rituximab.
- **Trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas:** control a largo plazo y mejor supervivencia en pacientes seleccionados con enfermedad difusa rápidamente progresiva, limitado por riesgos y costo.
- **La necesidad no cubierta:** no hay terapia modificadora aprobada para todos los pacientes, y la remisión sin fármacos sigue siendo una meta.

3 El mapa por mecanismo



Elaborado por Medicina en Resumen a partir de las tablas 1–3 y el texto de la revisión; no reproduce la figura del artículo. * Resultado conocido solo por comunicado de prensa. La ubicación por eje es simplificada: varios fármacos actúan en más de uno.

4 Lo que dice la revisión de cada grupo

ESTRATEGIA	QUÉ SE SABE HASTA AHORA (SEGÚN EL TEXTO)
CAR-T CD19	Serie de 6 pacientes con enfermedad difusa refractaria: estabilizó la EPI, mejoró el engrosamiento cutáneo y bajó los autoanticuerpos. En curso: resecabtagene autoleucel (fase 2), rapcabtagene autoleucel frente a rituximab (fase 2) y zolacaptagene autoleucel frente a tratamiento estándar en EPI (fase 3). Riesgos: citopenias, hipogammaglobulinemia, liberación de citocinas, neurotoxicidad.
CAR-NK y NK	Productos alogénicos "listos para usar", con menor expansión y quizá menos toxicidad; NKX019 (CAR-NK CD19) y NK no modificadas con rituximab en un ensayo canasta.
Eje BAFF/APRIL y FcRn	Belimumab: piloto de 20 pacientes seguro; ahora fase 2/3 en EPI y un ensayo con rituximab. Ianalumab, telitacicept y efgartigimod en fase 2 (piel o enfermedad global).
Interferón tipo I	Anifrolumab (aprobado en lupus): fase 1 en 34 pacientes redujo la firma de interferón; **fase 3** en esclerosis sistémica temprana con CRISS revisado como desenlace principal.
TL1A	Tulisokibart: fase 2 en EPI **negativa** para la CVF (comunicado de prensa; aún sin publicación).
sGC	Avenciguat: fase 2 de 48 semanas **negativa** en CVF y secundarios.
PDE4B	Nerandomilast: aprobado por la FDA para fibrosis pulmonar idiopática y fibrosis pulmonar progresiva; en esclerosis sistémica, fase 2 en EPI temprana (plataforma CONQUEST) y una fase 3 aparte.
Células mesenquimales	Fase 1/2 de 20 pacientes refractarios: seguridad aceptable, posible mejoría de piel y estabilidad de CVF en algunos.

5 Cómo leer esta revisión

- **Narrativa no es sistemática.** INTERPRETACIÓN La búsqueda fue estructurada pero en un solo registro y para inventariar ensayos, no para medir efectos. No hay evaluación de riesgo de sesgo ni síntesis cuantitativa. Sirve como mapa, no como respuesta a "¿funciona?".
- **Registrado no es positivo.** La mayoría está en fase 2, con desenlaces sustitutos; dos de los fármacos del mapa ya fallaron su fase 2.

- **El salto del ratón al paciente.** DATO DEL ARTÍCULO Gran parte del racional viene de modelos de bleomicina o Fra-2 y de otras enfermedades (dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria intestinal, Sjögren, lupus). INTERPRETACIÓN Es plausibilidad biológica, no eficacia.
- **Comunicados de prensa.** El resultado de tulisokibart y el de efgartigimod en miopatía inflamatoria se citan por comunicado: sin datos revisados por pares.
- **Desenlaces.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores advierten que Rodnan y CVF son sensibles al cambio pero no siempre se traducen en beneficio clínico, y piden desenlaces multidominio (CRISS revisado, índices de actividad, tiempo al empeoramiento clínico).
- **Conflictos de interés.** INTERPRETACIÓN Varios autores asesoran a las compañías de los productos revisados. No invalida el inventario, pero conviene leer con ese contexto el optimismo sobre algunos fármacos.

CONCEPTO CLAVE · DE "EN ENSAYO" A "EN LA CONSULTA"

INTERPRETACIÓN Para que una molécula del mapa cambie tu práctica necesita: (1) un ensayo fase 3 aleatorizado positivo en un **desenlace clínicamente relevante**; (2) publicación revisada por pares, no solo un comunicado; (3) seguridad aceptable en una enfermedad con vasculopatía (relevante, por ejemplo, para los inhibidores JAK, como señala la propia revisión), y (4) aprobación y acceso local. Ninguna de las de esta revisión cumple hoy los cuatro.

6 Los retos que señalan los autores

Seleccionar mejor a los pacientes (índices de actividad, biomarcadores, endotipos moleculares); intervenir en fases inflamatorias o prefibróticas; no olvidar la vasculopatía (el sotatercept ya funcionó en hipertensión arterial pulmonar, incluida la asociada a esclerosis sistémica), y medir con desenlaces multidominio.

Pregunta de repaso: un paciente con esclerosis sistémica difusa leyó que "el CAR-T cura la esclerodermia" y pregunta si debe pedirlo en lugar del micofenolato. ¿Qué le dices con base en esta revisión?

Respuesta. Que es una de las estrategias más prometedoras, pero la evidencia en esclerosis sistémica viene de series pequeñas (una de 6 pacientes) y hoy se evalúa en ensayos fase 2 y 3. Fuera de un ensayo clínico, el tratamiento sigue siendo el estándar por órgano (micofenolato como inicial en la EPI) y, en casos seleccionados, el trasplante autólogo. Si es refractario, vale la pena referirlo a un centro que participe en ensayos.

¿Qué aprendí de medicina?

- El estándar sigue siendo micofenolato y tratamiento por órgano; trasplante autólogo en seleccionados.
- Lo más avanzado: CAR-T CD19 (fase 3 en EPI), anifrolumab (fase 3) y nerandomilast (fase 3).
- Tulisokibart y avenciguat ya fueron negativos en fase 2.
- La tendencia: depleción B profunda y tratar más temprano.

¿Qué aprendí de investigación?

- Revisión narrativa = mapa; no responde "¿funciona?".
- Un ensayo registrado no es un ensayo positivo.
- Modelo animal = plausibilidad, no eficacia.
- Busca desenlaces clínicos, no solo sustitutos.

7 Referencias

1. Naveed E, Lescoat A, Matucci-Cerinic M, et al. Emerging drugs in phase 2/3 and selected phase 1/2 cellular-therapy trials: a glimpse into the future of systemic sclerosis treatment. *Ann Rheum Dis*. 2026. doi:10.1016/j.ard.2026.09.015
2. Müller F, Taubmann J, Bucci L, et al. CD19 CAR T-Cell Therapy in Autoimmune Disease — A Case Series with Follow-up. *N Engl J Med*. 2024;390:687-700. doi:10.1056/NEJMoa2308917 (ver El artículo explicado N.º 10)

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.